

Postrauematische Belastungsstörung

Definition:

Verzögerte oder protrahierte Reaktion, die innerhalb von 6 Monaten nach einem traumatischen, emotional belastenden Ereignis eintreten kann. Die posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zählt somit zu den spezifischen Traumafolgestörungen. Gekennzeichnet ist sie durch eine Erschütterung des Selbst- und Weltbildes. Leitsymptome sind ein Wiedererleben des Traumas („Flashbacks“), Vermeidung traumaassoziierter Stimuli und Hyperarousal. Eine Chronifizierung ist möglich (ca. 20–30% der Fälle).

Ätiologie:

Ursache:

Erleben oder Beobachten eines traumatischen Ereignisses

- Typ-1-Trauma: Kurzfristiges, plötzliches Auftreten
- Typ-2-Trauma: Länger andauerndes, mehrfaches Auftreten
 - Entscheidend ist hierbei Schwere des Traumas (Art und Dauer)
 - Subjektive Bewertung sowie erlebter Kontrollverlust

Risikofaktoren:

- Prätraumatisch: Traumatische Kindheitserfahrungen, vorherige Traumatisierungen, psychische Erkrankungen, weitere Faktoren
- Peritraumatisch: Hoher empfundener Autonomieverlust, plötzliches Auftreten des Traumas, subjektiv hohe wahrgenommene Lebensgefahr, langandauernde dissoziative Symptome, zwischenmenschliche Gewalt („Man-made-Trauma“)
- Posttraumatisch: Mangelnde soziale Unterstützung, körperliche Verletzungen, Schmerzen, anhaltender Stress, fortgesetzte Dissoziationsneigung, eigene Schuldzuweisung, sekundäre Belastungen, Alkoholmissbrauch

Schutzfaktoren:

- Peritraumatisch: Hohe Selbstwirksamkeitserwartung
- Posttraumatisch: Soziale Unterstützung, Schutz vor weiteren Belastungen, hohes Kohärenzgefühl

Integrativ biologisches Erklärungsmodell:

Veränderte Verarbeitung angstauslösender Stimuli im Gehirn

- „Normaler“ Weg: Thalamus → Assoziationskortex → Orbitofrontaler Kortex und Hippocampus → Amygdala
- „Verkürzter“ Weg (pathologisch): Thalamus → Amygdala
 - Folge: Ausbildung eines sog. Traumagedächtnisses

- Mögliche Einflussfaktoren zur Ausbildung des Traumagedächtnisses:
Hypocortisolismus → Erhöhte Katecholaminfreisetzung bei Stress → Inhibition des präfrontalen Kortex, Disinhibition der Amygdala

Prognose:

- Mittlere Dauer: ♀: 48 Monate; ♂: 12 Monate (Symptome >3 Monate prognostisch ungünstig)
- Remission
 - Vollständige Remission in den ersten 3 Monaten bei 50% der Fälle
 - Eine andere Quelle nennt eine Spontanremission von 50% nach 4 Jahren
 - Symptome entwickeln sich bei den meisten Betroffenen innerhalb weniger Wochen bis Monate zurück
 - 80–90% Remission
- Chronifizierung
 - In ca. 20–30% der Fälle
- Verzögerte PTBS: Entwickelt sich bei ca. 7% (nach >6 Monaten)
- Komplikation: Kann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung (F62.0) übergehen

Symptome:

Die Symptomatik der posttraumatischen Belastungsstörung ist vielfältig.

- Wiedererinnerung: Häufig ausgelöst durch einen Schlüsselreiz (sog. „Trigger“)
 - Intrusionen: Eindringliches, ungewolltes Erinnern und Wiedererleben psychotraumatischer Ereignisse bei erhaltener Realitätskontrolle
 - Flashbacks: Ausgeprägte Form der Intrusion
 - Traumatisches Ereignis wird durch Gedanken, Gefühle und Bilder erneut erlebt
 - Realitätskontrolle i.d.R. nicht mehr erhalten
 - Intrusive Bilder
 - Alpträume
- Vermeidungsverhalten
 - Vermeidung von Gesprächen, Situationen, Orten etc., die mit Trauma in Verbindung stehen oder gebracht werden
 - Emotionale Taubheit (Numbing)
 - Partielle Amnesie: Erinnerungsbeeinträchtigung in Bezug auf das traumatische Ereignis

- Hyperarousal
 - Psychische Übererregung: Reizbarkeit, erhöhte Anspannung, Wutausbrüche, Schlafstörungen, Konzentrationsschwierigkeiten, übermäßige Wachsamkeit, erhöhte Schreckhaftigkeit
 - Vegetative Übererregung: Tachykardie (subjektiv Herzklopfen oder -rasen), Engegefühl in der Brust, Atembeschwerden, Zittern
- Weitere Symptome
 - Depressivität: Interessenverlust, Anhedonie, emotionale Abstumpfung und sozialer Rückzug
 - Anhaltende negative Einstellungen und verzerrte Kognitionen, bspw. bzgl. der Schuldzuweisung
 - Dissoziative Symptome : Bspw. dissoziative Amnesie, Derealisation, Depersonalisation, Abwesenheit, Lähmungen
 - Suizidgedanken
 - Symptombedingt folgen meist psychosoziale Komplikationen: Bspw. Arbeitsplatzverlust oder Konflikte in zwischenmenschlichen Beziehungen
- Komorbiditäten

Merke: komorbide Störungen sind bei der PTBS häufig!

 - Psychische Störungen: Affektive Störungen, Suchterkrankungen, Somatisierungsstörungen, Psychosen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen, Angst- und Zwangsstörungen
 - Somatische Störungen: Arterielle Hypertonie, Asthma, chronische Schmerzsyndrome, rheumatische Erkrankungen

CAVE: Die Rate an Suizidversuchen ist bei Vorliegen einer PTBS ca. 8-fach erhöht.

Diagnostik:

Diagnostische Kriterien nach ICD-10

- Kriterium A – Traumatisches Ereignis: Voraussetzung ist die Exposition gegenüber einem Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophalem Ausmaß, das bei nahezu jedem Menschen tiefe Verzweiflung auslösen würde.
- Kriterium B – Wiedererleben: Das Trauma drängt sich in Form von unwillkürlichen Erinnerungen, Flashbacks und Alpträumen wiederholt ins Bewusstsein.
- Kriterium C – Vermeidungsverhalten: Es zeigt sich ein neu aufgetretenes Vermeidungsverhalten, das in direktem Zusammenhang mit dem traumatischen Erlebnis steht.

- Kriterium D – Amnesie oder Übererregung: Zusätzlich muss entweder ein vollständiger oder teilweiser Erinnerungsverlust an das traumatische Ereignis vorliegen, oder es bestehen anhaltende Symptome einer Übererregung mit mindestens zwei der folgenden Merkmale: Ein- und Durchschlafstörungen, Reizbarkeit oder Wutausbrüche, Konzentrationsschwierigkeiten, Hypervigilanz sowie erhöhte Schreckhaftigkeit.
- Kriterium E – Zeitkriterium: Sämtliche Symptome müssen innerhalb von sechs Monaten nach dem traumatischen Erlebnis oder nach Ende einer Belastungsperiode aufgetreten sein; in begründeten Ausnahmefällen kann auch ein späterer Beginn diagnostisch berücksichtigt werden.

Therapie:

Psychotherapie der PTBS

- Frühintervention: Bei akuter Symptomatik wird auf die Therapieansätze der akuten Belastungsreaktion verwiesen.
- Methode der Wahl – Traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Nach einer initialen Stabilisierungsphase umfasst die KVT typischerweise folgende zentrale Bausteine: imaginative Exposition, narrative Exposition, Exposition in vivo sowie kognitive Umstrukturierung. Zu den etablierten Verfahren zählen die Prolongierte Exposition nach Foa, die Kognitive Verarbeitungstherapie nach Resick, die Kognitive Therapie nach Ehlers und Clark, die Narrative Expositionstherapie (NET) sowie verschiedene Kombinationen aus expositionsbasierten und kognitiven Ansätzen.
- Methode der Wahl – EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): Unter therapeutischer Anleitung wird die Traumaszene innerlich wachgerufen, während die Augen gleichzeitig den sich von links nach rechts bewegend den Fingern der behandelnden Person folgen.
- Phasenbasierte Ansätze bei komplexer PTBS: Für die Behandlung der komplexen PTBS kommen phasenorientierte Verfahren zum Einsatz, insbesondere das Skills-Training zur affektiven und interpersonellen Regulation kombiniert mit narrativer Therapie (STAIR/NT) sowie die Dialektisch-Behaviorale Therapie für PTBS (DBT-PTBS).

Pharmakotherapie:

Eine Pharmakotherapie ist nur adjuvant (oder alternativ bei Ablehnung oder fehlender Möglichkeit einer Psychotherapie) anzuwenden. Patient:innen sollten darüber aufgeklärt werden, dass ein therapeutischer Effekt bei der Behandlung mit Antidepressiva deutlich zeitverzögert eintritt.

- **Mittel der Wahl:**

Sertralin (25mg 1-0-0, nach einer Woche auf 50mg 1-0-0 und max 200mg am Tag) oder

Paroxetin (10mg 1-0-0, Erhaltungsdosis 20mg 1-0-0 und max am Tag 50mg, bei Personen über 65 nur 40mg)

- **Initial:** Zu Beginn etwas niedrigere Dosierung als üblich wählen, da PTBS-Patienten meist empfindsamer auf Nebenwirkungen reagieren
- **Erhaltungsdosis**
 - Mind. 8–12 Wochen eher hohe Erhaltungsdosis, da Effekt meist später als bei Depressionen einsetzt
 - Erhaltungstherapie mind. 1 Jahr; bei persistierender Restsymptomatik mind. 2 Jahre
- **Alternativ (Off-Label Use):** Venlafaxin (initial 37,5 mg p.o., langsame Dosissteigerung in Zwei-Wochen-Schritten bis max. 375 mg/Tag)